

Organisation du système de santé

Notre système de santé est principalement **Bismarckien**, c'est à dire qu'il est défini par un pluralisme géré par des conventions entre les acteurs. La médecine est une pratique majoritairement libérale et les pouvoirs publics soutiennent les institutions de soins. Comme sécurité sociale, on se rappelle que l'on a l'assurance maladie obligatoire, l'assurance accident et l'assurance invalidité.

Les rôles de l'Etat sont les suivants :

- Assurer une offre suffisante
- Garantir la sécurité
- Garantir la solidarité et l'équité
- Maitriser les coûts

Le fédéralisme suisse vise à éviter la concentration des pouvoirs. Elle permet une autonomie des membres et une délégation des pouvoirs (organisation avec une certaine autonomie au niveau des cantons). Le principe de subsidiarité signifie que le niveau fédéral va intervenir (se substituer) seulement quand le niveau cantonal n'arrive pas à faire ce qu'il devrait faire de manière correcte.

La 1^{ère} raison pour laquelle les cantons ont donné du pouvoir à la Confédération c'était pour pouvoir pratiquer la médecine dans tous les cantons et pas seulement dans le canton de formation (loi sur l'exercice des professions médicales). La 2^e loi promulguée au niveau fédéral c'était la loi sur les épidémies.

Le département fédéral de l'intérieur a plusieurs offices qui vont s'occuper de diverses tâches : OFAS, OFS, OFSP et Swissmedic. La conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires correspond à la rencontre entre les Ministres de la santé publiques des différents cantons.

1. Compétences de la Confédération

La Confédération a des compétences dans certains champs : **contrôle des maladies infectieuses** (loi sur les épidémies, loi sur la lutte contre la TB), **toxicomanies et environnement** (loi sur les stupéfiants, loi sur l'alcool et le tabac), **maladies chroniques et psychiques** (loi contre les maladies rhumatismales) et **protection des travailleurs et prévention des accidents**.

La loi sur les épidémies vise une éradication des maladies transmissibles, très répandues ou virulentes chez l'homme et l'animal comme la tuberculose, le VIH, le SARS ou encore la grippe aviaire. La Confédération subventionne également la lutte contre les maladies rhumatismales.

La Confédération effectue également d'autres actions :

- **Surveillance et sécurité** : contrôle des médicaments, vaccins, sérums, greffe, transplantation, contrôle des denrées alimentaires, contrôle des stupéfiants et des toxiques
- **Lutte contre les dépendances** : alcool (taxe prélevée pour l'AVS et pour la lutte contre l'alcoolisme), tabac et toxicomanie
- **Encouragement de la gymnastique et des sports**
- **Contribution financière à la prévention des accidents**
- **Protection de la santé au travail**
- **Formation des professions de la santé** : médecins et autres professions de la santé
- **Assurances sociales** : maladies, accidents, invalidité, militaire et maternité
- **Statistiques sanitaires**
- **Commission nationale d'éthique**

- Relations internationales

L'administration centrale comprend l'Office Fédéral de la Santé Publique (protection de la santé, surveillance des maladies, programmes nationaux de prévention, commission nationale d'éthique en médecine humaine et définition du catalogue des prestations), l'Office Fédéral de la Statistique et l'Office Fédéral des Sports. On a aussi des unités administratives décentralisées comme les Fonds de Prévention du Tabagisme (rattaché à l'OFSP) et le Régie Fédérale des Alcools (rattachée au DFF).

Finalement, on a encore des institutions indépendantes ou des fondations à mandat légal comme la SUVA, le Bureau Suisse de la Prévention des Accidents, les fonds pour la sécurité routière et **Promotion Santé Suisse**.

1.1 Promotion Santé Suisse

Promotion Santé Suisse est une fondation créée en 1989 par les cantons et les assureurs maladies. Les bases légales sont les suivantes :

- Les assureurs **encouragent la prévention des maladies**
- Ils gèrent en commun et avec les cantons une institution dont le but est de **stimuler, coordonner et évaluer des mesures destinées à promouvoir la santé et à prévenir les maladies**. Le Conseil fédéral crée l'institution si les assureurs et les cantons ne l'ont pas fait.
- L'organe directeur de l'institution est composé de **représentants** des assureurs, des cantons, de la CNA, de la Confédération, des médecins, des milieux scientifiques ainsi que des organisations spécialisées dans le domaine de la prévention.

Promotion Santé Suisse est financée par le prélèvement sur les cotisations de l'assurance maladie obligatoire, ce qui représente en tout 17 millions par année. Elle met sur place des programmes prioritaires de prévention concernant l'activité physique, l'alimentation, la détente, la santé et le travail, les adolescents, les jeunes adultes et la santé mentale. Elle a une fonction de conseil, d'encouragement, de coordination de projets nationaux ou régionaux et assure également un financement et des évaluations.

2. Compétences des Cantons

Les cantons doivent appliquer le droit fédéral et ils sont responsables de la planification et de l'organisation des services de santé comme les hôpitaux, les EMS, les soins à domicile et la médecine d'urgence et des catastrophes. Ils financent les hôpitaux et les institutions de soin. Ils sont responsables de l'approbation des conventions et des tarifs et ils **les fixent en absence de convention**.

Ils ont aussi un rôle dans **la formation** (universités) et ils doivent appliquer les prescriptions fédérales. Avec leur fonction de **surveillance**, ils délivrent des autorisations (professions et institutions) et ils ont finalement une fonction de prévention et de promotion de la santé (dîme de l'alcool).

3. Compétences des communes

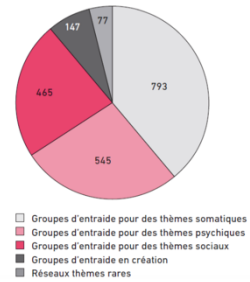
Les communes sont responsables des prestations de soins et des affaires sociales, surtout dans le médico-social (EMS, soins à domicile, psychiatrie ambulatoire, aide sociale). Elles ont aussi un rôle de prévention et de promotion de la santé (fonction présente dans les trois niveaux), elles assurent la sécurité publique, les secours et elles appliquent évidemment le droit cantonal.

4. Entraide

L'entraide est définie comme **toute forme d'action individuelle ou collective** entreprise par des personnes concernées (par la maladie ou le problème), dans le but de **prévenir ou de mieux faire face à une maladie, à un problème psychique ou social** sans recourir aux services de professionnels rémunérés.

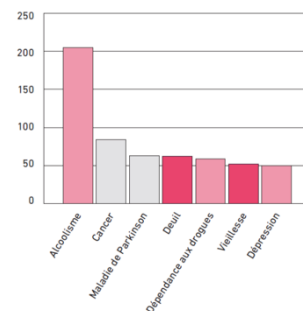
Les groupes d'entraide sont constitués autour d'un **vécu commun**, de malades ou de proches de malades, articulant des facteurs **individuels** (*self-help*) et des facteurs de **groupe** (*mutual help*). L'action est **libre et gratuite** à l'intérieur du groupe et il existe **une égalité entre les différents membres du groupe** (pas de hiérarchisation).

L'entraide existe depuis de nombreuses années, mais son essor s'est vraiment mis en place lors **des mouvements sociaux d'émancipation des années 1960** (*empowerment*). Les années 1970 se caractérisent par une coopération **face aux institutions savantes et professionnelles**, une définition **psychosociale** de la santé et une **critique du pouvoir médical**. Finalement, dans les années 1980, on a pu observer **une amplification des actions collectives et du contre-pouvoir** suite à l'épidémie de VIH.



Groupe d'entraide	Aide professionnelle
Savoir expérientiel	Connaissances scientifiques et savantes
Ressenti	Rationalité
Expérience communes et proximité	Distance
Engagement personnel, spontanéité, instinct	Engagement limité et technique

En Suisse, on recense près de 2'000 groupes d'entraide actifs dans le domaine santé-social, et ce nombre est en **constante augmentation**. Les rôles principaux des groupes d'entraide sont **les échanges d'expériences, les discussions de groupe, l'expression des sentiments et la diffusion d'informations pratiques**. Les groupes d'entraide peuvent concerner les domaines somatiques (majorité), psychiques et sociaux. Les groupes d'entraide pour l'alcool sont les plus nombreux et ils sont suivis par des groupes sur le cancer, la maladie de Parkinson ou encore la dépendance aux drogues.



Les groupes d'entraide **ne sont pas financés par l'Etat** car ils n'ont pas de base légale.

4.1 Coordination

Au niveau national, *la Fondation Info-Entraide Suisse* assure **la coordination et la promotion des groupes d'entraide**. Le financement est principalement assuré par l'OFAS, mais aussi par les cantons, les dons, et les prestations de services. Au niveau régional ou cantonal, on recense 19 centres Info-Entraide. Les buts de la FIES sont d'encourager l'entraide, **d'assurer une vision d'ensemble**, d'offrir un service d'accueil et des conseils pour les groupes et de procéder à une mise en réseau à des fins de *lobbying*.

5. Organisation Non-Gouvernementales.

Les ONG sont séparées **en associations, ligues et organisations** qui sont **dotées de schémas administratifs et juridiques**. Elles sont **en contact étroit** avec les systèmes professionnels et/ou contiennent des professionnels. Elles ont fréquemment recours à des bénévoles et contrairement aux groupes d'entraide, elles **bénéficient de soutiens étatiques**.

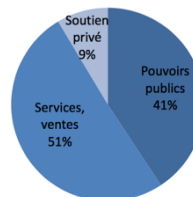
5.1 Pro Infirmis

Pro Infirmis est une **organisation privée indépendante** sous la forme d'une organisation faitière. Les membres sont des organisations du domaine du handicap qui prodiguent aide, conseils, moyens d'accompagnement, formation de personnes handicapées, financement de moyens auxiliaires et promotion de l'autonomie (> 20'000 clients par an). En plus, *Pro Infirmis* **s'engage également dans la politique sociale** et est financée par des contributions privées et publiques.

5.2 Pro Senectute

Pro Senectute a au départ été fondé pour aider les vieillards nécessiteux. Pro Senectute s'est ensuite **réorientée vers le conseil et la prestation de services** depuis la mise en place de l'AVS en 1948. Elle est divisée en 26 organisation cantonales et grâce à son contrat de prestations signé avec la Confédération, elle offre les prestations suivantes :

- **Aide à domicile** (repas, ménage, visites)
- **Travail social** (consultation, soutien)
- **Information** (médias, manifestations sur la vieillesse)
- **Activités sportives**
- **Formation des personnes âgées**



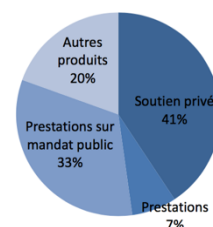
Pro Senectute emploie 5'400 collaborateurs mais a **plus de 10'000 bénévoles**. Elle est principalement financée **par le service et les ventes**, mais aussi par les pouvoirs publics.

5.3 Croix Rouge Suisse

Le CICR est fondé en 1863 et s'étend dans 17 pays. Au départ, son objectif était d'apporter une aide sanitaire à l'armée et permettre une coopération internationale. Actuellement, la Croix Rouge Suisse possède les buts suivants :

- **Promotion de la santé publique**
- **Aide d'urgence**
- **Service de transfusion sanguine**
- **Formation surtout dans les professions non-universitaires de la santé**

Il faut savoir qu'il existe un **arrêt fédéral** concernant la CRS. La Croix Rouge a **l'obligation**, en cas de guerre, **d'aider le Service de santé de l'armée**. Son status est soumis à l'approbation du Conseil Fédéral et elle a **la garantie d'un appui financier pour les tâches principales reconnues**, c'est à dire l'aide sanitaire volontaire, le service de transfusion sanguine, l'encouragement des soins infirmiers et les autres tâches humanitaires découlant des conventions de Genève et de résolutions de conférences internationales.



La Croix-Rouge Suisse est majoritairement financée par des dons privés, mais aussi par des prestations sur mandat publique.

6. Ligues

Les ligues ont été créées au début du 20^e siècle (premières structures d'infirmières visiteuses) et sont **des associations faitières d'organisation cantonale et/ou régionales**. Ces ligues sont très orientées sur des pathologies particulières (ligue pulmonaire, ligue contre le cancer, ligue contre les rhumatismes).

6.1 Ligue pulmonaire

La **ligue pulmonaire suisse** regroupe 24 sections cantonales (300 personnes). Elle **assure la prise en charge des aspects non-médicaux** (appareillages, soutien social, aides financière et administrative), informe le public et procède à des enquête d'entourage et à la distribution médicaments en cas de **tuberculose**. Elle forme aussi des professionnels et promeut la santé.

Les ligues cantonales effectuent donc un important travail de terrain .
--

"Les ligues de la santé" correspond à une coordination vaudoise qui regroupe 6 membres suit à la demande du service de la santé publique du canton de Vaud (association vaudoise du diabète, fondation de la mucoviscidose,

fondation vaudoise contre l'alcoolisme, ligue pulmonaire vaudoise, ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires et ligue vaudoise contre le rhumatisme).

7. Conclusion

En principe, les cantons ont les compétences en matière de prévention et de promotion de la santé, sauf dans les catégories suivantes qui sont prise en charges par **la Confédération** :

- Maladies transmissibles
- Promotion de l'exercice et du sport
- Protection de la santé des travailleurs
- Taxation sur le tabac et l'alcool
- Dépendances
- Maladies rhumatismales
- LAA

Le rôle de travail **sur le terrain** est majoritairement **laissé aux ONG**. Les **groupes d'entraide** représentent un contre-pouvoir par rapport aux institutions et aux professionnels de la santé, tandis que **les ONG** représentent **le 4^e pouvoir** au côté de la confédération, des cantons et des communes. L'Etat s'appuie sur les ressources des ONG et inversement, les ONG s'appuient sur les ressources de l'Etat. Il existe des tentatives d'inscription de l'activité de prévention et de promotion de la santé des ONG dans un cadre de politique fédérale et cantonale.

En somme, on retient qu'il existe une multiplicité des acteurs et un enchevêtrement des compétences et des financements. Le système est **décentralisé**, mais on assiste à un **élargissement progressif** des compétences de la Confédération. Cela entraîne un coût élevé, mais les indicateurs de santé sont favorables. Finalement, on note que la LAMal agit comme **un instrument de régulation** au niveau fédéral.